

Material de supervisión

Sesión N° 1, 06/08/2026

La sesión muestra una primera entrevista de tono activo y estructurado, en la que el terapeuta despliega herramientas de defusión cognitiva (ACT) desde los primeros minutos. El encuentro tiene momentum clínico: la paciente responde con apertura creciente y termina con un compromiso conductual concreto. Al mismo tiempo, la velocidad y la densidad de intervenciones dejan poco espacio para que emerja material más profundo sobre la historia de la paciente.

Punto 1 — La urgencia de intervenir y el ritmo acelerado de la sesión

Desde el inicio, la paciente describe un torbellino de pensamientos y el terapeuta interviene con rapidez: metáforas, preguntas socráticas, técnicas de defusión, proyección al futuro, plan de acción. La sesión es muy activa. Lo que queda menos explorado es el por qué ahora, la historia de esa sensación de "no ser suficiente" que la paciente misma ubica como algo previo ("siempre fue un poco así, incluso antes"). Ella lo dice de pasada y el terapeuta no se detiene ahí.

La contratransferencia no está descripta explícitamente, pero el ritmo sostenido de intervenciones podría señalar algo: ¿había una presión interna a "hacer algo útil" rápidamente, a demostrar que la terapia funciona? Vale la pena explorar si esa urgencia resonaba con algo de la paciente —su propia dificultad para tolerar la inacción— o si venía del lado del terapeuta.

Hipótesis a testear:

- La creencia "no soy suficiente" no es reactiva a la situación laboral actual sino una organización más temprana del self, que el período de crianza quitó del primer plano pero no resolvió.
- El ritmo acelerado de la sesión puede estar funcionando, paradójicamente, como un espejo del propio estilo rumiativo de la paciente: mucho movimiento, poca pausa.

Punto 2 — "Solo alguien en mi lugar podría entenderme": la demanda implícita de reconocimiento

En un momento temprano, la paciente dice algo significativo: "hay que estar en mi lugar, porque si no no creo que entiendas". El terapeuta no recoge explícitamente ese momento; en cambio, refleja el contenido cognitivo y avanza. Es un momento que merece atención: ¿es una prueba de vínculo? ¿Una expectativa de no ser comprendida que se anticipa como defensa? ¿Un pedido de validación que, si no se satisface, podría erosionar la alianza más adelante?

La intervención del terapeuta en ese punto fue validar el contenido (la cantidad de ideas que "revolotean") sin abordar la dimensión relacional del comentario. Puede haber sido una elección

técnica deliberada —no confrontar en primera sesión— o puede haber sido un paso en falso silencioso.

Hipótesis a testear:

- La paciente tiene un patrón de anticipar la incomprensión de los otros, que probablemente se repite en múltiples vínculos (pareja, hijos, futuro empleador) y que podría instalarse también en la relación terapéutica.
- Si ese momento no se trabaja, puede convertirse en un punto de ruptura de alianza poco visible: la paciente cumple tareas pero siente que no es verdaderamente vista.

Nota sobre proceso paralelo: Al llevar este material a supervisión, vale observar si el terapeuta siente necesidad de "demostrar" que la sesión funcionó bien, o si puede sostener también la incertidumbre sobre lo que quedó sin explorar. Esa misma dinámica —la urgencia de ser suficiente— puede estar presente en la sala de supervisión.

Punto 3 — El compromiso conductual y sus condiciones de posibilidad

La sesión cierra con un plan concreto: la paciente se compromete a actualizar su currículum al día siguiente. Es un logro técnico real. La paciente muestra motivación genuina al final y el terapeuta usa bien la visualización de consecuencias para movilizarla. Sin embargo, el compromiso fue construido en un estado emocional activado positivamente —casi de entusiasmo— dentro de la sesión. Queda la pregunta de qué ocurrirá cuando esté sola frente al documento.

El terapeuta anticipa que "vendrán los pensamientos" y ofrece la defusión como herramienta. Lo que no queda del todo consolidado es si la paciente tiene suficiente práctica con esa habilidad para usarla en solitario después de una sola sesión.

Hipótesis a testear:

- El compromiso conductual, aunque valioso, puede estar sostenido más por el vínculo incipiente con el terapeuta que por una habilidad internalizada; si la tarea no se cumple, el riesgo es que se reactive la narrativa de fracaso con mayor fuerza.
- La "cruda realidad" que la paciente menciona al pensar en abrir el currículum puede contener material emocional aún no explorado —vergüenza, duelo por años no laborados— que excede la defusión cognitiva y que requerirá espacio en sesiones siguientes.